

Uno studente nel vostro ambulatorio

Per medici di famiglia, servizi sanitari e di salute mentale universitari — nella cura di uno studente universitario autistico (circa 18–25 anni).

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di uno studente si blocca in pochi „tunnel” profondi e intensi. L'università è una transizione *enorme*: nuova autonomia, meno struttura, tutto open-space, lavori di gruppo e pressione sociale. Molti studenti autistici fiorivano sotto la prevedibilità della scuola e poi **hanno incontrato un muro** — burnout, ansia o crisi nel primo o secondo anno. I loro interessi focalizzati sono una forza genuina; il sistema attorno a loro è di solito il problema.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
„Stava bene”, ora non frequenta, non si lava, non mangia o non funziona	Burnout autistico dal carico cumulativo di un ambiente ad alto canale e imprevedibile
Ansia, depressione, collasso del sonno, disturbi alimentari	Co-occorrenze comuni; anche segnali di sovraccarico, non solo malattia primaria
Salta le lezioni, manca le scadenze; sembra „pigro”	Inerzia autistica + carico esecutivo sotto esaurimento cronico
Diagnosticato solo ora, in crisi	L'università è un punto comune di identificazione tardiva („generazione perduta”)
Preferisce le email; evita chiamate, contatto visivo, contesti di gruppo	Comunicazione a canale singolo, letterale; il contatto scritto riduce il carico

Provate questo

- **Offrite appuntamenti online/telefonici o scritti in primo luogo**; permettete un accompagnatore e un kit sensoriale.
- **Screenate specificamente il burnout autistico** — esaurimento, perdita di abilità possedute, ridotta tolleranza agli stimoli — e trattatelo come distinto dalla depressione.
- **Riducete e strutturate**: sostenete gli adeguamenti tramite il servizio disabilità dell'università (spazio d'esame silenzioso, prevedibilità di calendario, istruzioni scritte).
- **Chiedete degli interessi e del recupero** — proteggete l'accesso; il riposo e „fare le cose a modo autistico” fanno parte della ripresa.
- **Pianificate la continuità** attraverso le vacanze e il passaggio alla vita adulta/da laureato.

Evitate questo

- Ridurre a „stress/ansia tipica dello studente” e mancare il burnout o una prima identificazione dell'autismo.
- Consigliare approcci generici di abilità sociale o „tieni duro” che aumentano il mascheramento.
- Dare per scontato che coinvolgimento = contatto visivo e fluidità verbale.

Quando serve altro supporto

Screenate direttamente la suicidalità e il burnout severo. Segnalate il **servizio disabilità/di scoperta dell'università**, il mentoring e le comunità di studenti autistici. Considerate una **riduzione temporanea del carico accademico** o un'interruzione degli studi come passo di recupero legittimo e allineato alle evidenze — non un fallimento. Affrontate le condizioni co-occorrenti di ADHD, ansia, sonno e problemi gastrointestinali.

Se lo studente è una donna

Le donne e gli studenti di genere marginalizzato sono sovrarappresentati tra gli studenti identificati tardi e spesso mascherano intensamente. Una presentazione „ad alto rendimento, socievole in superficie” con collasso privato è uno schema chiave — chiedete del divario tra performance pubblica ed esaurimento privato.

Informazioni su questa guida

*Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la sintesi sul **Monotropismo** e la guida **Lifespan per professionisti e sanitari** (Parti 3.3–3.4 e 4). Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico.** Adattatela al/dalla singolo/a.*

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Pearson & Rose (2021); Knight (2021, *tunnel non compiti*); AASPIRE AHAT. Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.